

Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2

Tratamiento Escalonado de la DM Tipo 2

Paso a paso

TABLA 2.8.1: PASO VS ACCIÓN	
PASO	ACCIÓN
1	Cambio de estilo de vida (dieta, ejercicio, no fumar) + Metformina desde el diagnóstico
2	Aumentar dosis de metformina (máximo 3 g/día; prácticamente: 2 g/día)
3	Agregar 2º HGO (sitagliptina, liraglutida, glibenclamida según recursos/riesgo)
4	2º HGO en dosis máxima (glibenclamida hasta 20 mg/día; sitagliptina hasta 100 mg/día)
5	Agregar insulina NPH nocturna 10 UI subcutánea nocturna
6	Aumentar NPH nocturna (si glicemia ayuno sigue alta) o agregar NPH matinal (si prealmuerzo/pre-cena altas)
7	Agregar insulina cristalina pre-comidas si postprandiales siguen altas con precomidas normales

¿Qué pasa con los HGO cuando inicio insulina?

- **Metformina: mantener** (ayuda a evitar el alza de peso)
- Otros HGO: pueden suspenderse o mantenerse (sin evidencia definitiva → decisión por recursos, polifarmacia y peso)

Inicio directo de insulina (HbA1c > 9%)

- Si ya está con 2 HGO en dosis máxima y HbA1c > 9% → **iniciar insulina directamente**
- Alternativa: agonistas GLP1 (si hay recursos) en vez de insulina cuando HbA1c muy alta

Selección de 2º HGO por comorbilidad

TABLA 2.8.2: SITUACIÓN VS HGO DE ELECCIÓN		
SITUACIÓN	HGO DE ELECCIÓN	
Sin comorbilidades, con recursos	Sitagliptina (DPP4) o liraglutida (GLP1)	
Sin recursos	Glibenclamida	
Riesgo de hipoglicemia alto (> 75 años)	Sitagliptina / GLP1 (no glibenclamida)	
IRC con macroalbuminuria	GLP1 + iSGLT2	
Insuficiencia Cardíaca: Generalidades	Insuficiencia cardíaca	iSGLT2 (empagliflozina)
IRC CICr < 30 + IC	Insulina	

EUNACOM CRITERIOS
Metformina contraindicada si: CICr < 30 o IC severa.
Glibenclamida contraindicada si: > 75 años, hipoglicémicos, falla renal.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Paciente de 50 años, diagnosticado con DM2 hace 1 mes, IMC 32, sin comorbilidades cardiovasculares ni renales. HbA1c 7.8%. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tratamiento de la Diabetes Mellitus Tipo 2. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

- PUNTOS CLAVE DESTACADOS**
- Objetivo general de HbA1c <7%. En adultos mayores frágiles, <8%. En jóvenes sin comorbilidades, <6.5%.
 - Primera línea siempre: cambios de estilo de vida + metformina.
 - Reevaluar a los 3 meses: si no se logra objetivo, agregar segundo fármaco.
 - Con ECV ateroesclerótica: preferir aGLP-1 o iSGLT-2.
 - Con ICC o ERC: preferir iSGLT-2.
 - La metformina se mantiene siempre que no esté contraindicada, incluso con insulina.
 - Insulinización cuando HbA1c >9-10% a pesar de terapia oral optimizada o síntomas catabólicos.
 - La terapia es escalonada y centrada en el paciente.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2)

PREGUNTA 1

Paciente de 50 años, diagnosticado con DM2 hace 1 mes, IMC 32, sin comorbilidades cardiovasculares ni renales. HbA1c 7.8%. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?

- A) Insulina glargina subcutánea
- B) Metformina más cambios de estilo de vida
- C) Glibenclamida en monoterapia
- D) Empagliflozina más metformina desde el inicio
- E) Solo cambios de estilo de vida sin fármacos

PREGUNTA 2

Paciente de 62 años con DM2 en tratamiento con metformina 2 g/día hace 6 meses. HbA1c actual 8.2%. Tiene antecedente de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Cuál es el fármaco más adecuado para agregar?

- A) Glimepirida
- B) Pioglitazona
- C) Dapagliflozina
- D) Sitagliptina
- E) Insulina NPH

PREGUNTA 3

Paciente de 82 años, frágil, con múltiples comorbilidades, DM2 con HbA1c de 7.3%. ¿Cuál es el objetivo de HbA1c más adecuado para este paciente?

- A) HbA1c menor a 6.0%
- B) HbA1c menor a 6.5%
- C) HbA1c menor a 7.0%
- D) HbA1c menor a 8.0%
- E) No es necesario medir HbA1c en mayores de 80 años

RESUMEN: TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

El tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 se basa en un enfoque escalonado que comienza siempre con cambios en el estilo de vida (dieta y ejercicio) más metformina como fármaco de primera línea. El objetivo terapéutico general es una HbA1c menor a 7%, aunque en adultos mayores frágiles o con comorbilidades severas se acepta un objetivo menos estricto de HbA1c menor a 8%. Si con metformina en monoterapia no se logra el objetivo en 3 meses, se agrega un segundo fármaco. La elección de la segunda línea depende del contexto clínico del paciente: si tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, se prefiere un agonista de GLP-1 o un inhibidor de SGLT-2. Si tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, se prefiere un inhibidor de SGLT-2. Si no tiene ninguna de estas comorbilidades, se puede agregar cualquier agente disponible según costo y preferencia. Si con la terapia dual tampoco se logra el control, se puede agregar un tercer fármaco oral o iniciar insulina basal. La insulinización se considera cuando la HbA1c persiste sobre 9-10% a pesar de terapia oral optimizada, o cuando hay síntomas catabólicos como polidipsia, poliuria y baja de peso involuntaria. Es importante recordar que la metformina se mantiene siempre que no esté contraindicada, incluso cuando se agrega insulina.